прос: «Дает ли вам врач всю необходимую информацию относительно лечения вашего ребенка». Относительно вопроса об информировании родителей больного ребенка о возможных побочных действиях то или иного лекарственного препарата утвердительно ответили 61 опрошенный, что составляет 67,7% от всех опрошенных. На вопрос: «Повторяет ли врач неясную для вас информацию относительно реабилитации вашего ребенка» утвердительно ответили 66 опрошенных, что составляет 73,3% из общего числа опрошенных.

**Заключение.** Таким образом, уровень комплайенса у стационарных больных составляет 75,8%, что указывает о недостаточно высоком уровне комплайенса у родителей больных детей с медицинскими работниками.

## Оценка эффективности клинических тестов в прогнозировании развития критических дыхательных расстройств у детей раннего возраста

**Умарова З.С., Джубатова Р.С., Хакимов Д.П., Кариева Ш.А.**

*Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан*

В педиатрической практике используются ряд клинических тестов для выявления дыхательных расстройств, диагностики заболевания, вызвавшего их, для прогнозирования развития критического состояния. Большая часть их проявляются в поздние сроки развития, некоторые не оценены в доказательных исследованиях. Практический интерес представляют тесты, выявляемые рано и обладающие прогностической ценностью.

**Цель.** Изучить прогностическую ценность клинических тестов развития дыхательных расстройств у детей раннего возраста.

**Пациенты и методы.** Проведено когортное исследование, в котором проспективно обследовано 356 детей в возрасте от 2 мес до 3 лет, поступивших приемное отделение с признаками дыхательных растройств. Для контроля было исследованы 320 детей в этом же возрасте, у которых не развилось критическое респираторное состояние. Оценены чувствительность и специфичность каждого теста. Диагноз и прогноз верифицировался по исходу заболевания.

**Результаты.** Были выявлены значимые показатели чувствительности (Ч) и специфичности (С) в прогнозировании развития критических дыхательных расстройств: изменение оральных звуков, таких ка свист (Ч – 81%, С – 65%), стридор (Ч – 89%, С – 70%), грантинг (Ч – 93%, С – 74%), хрип на выдохе (Ч – 68%, С – 53%), психомоторное возбуждение (Ч – 64%, С – 51%) или угнетение (Ч – 75%, С – 58%), частота дыхательных движений более 30 у детей до года, более 40 у детей старше года (Ч – 77%, С – 65%), тахикардия (Ч – 54%, С – 48%) и брадикардия (Ч – 84%, С – 89%), периоральный цианоз заходящий на подбородок при плаче (Ч – 95%, С – 87%), удлинение длительности выдоха более 9 секунд (Ч – 95%, С – 89%), более 3 баллов по шкале Alder Hey (Ч – 88%, С – 71%), набухание яремных вен (Ч – 82%, С – 66%), увеличение границ тупого звука при перкуссии С7-Т2 (Ч – 91%, С – 83%) и ниже яремной вырезки (Ч – 78%, С – 58%), курение родителей (Ч – 86%, С – 79%), прием стероидов последние 3 мес (Ч – 83%, С – 88%).

**Вывод.** Полученные данные позволяют рекомендовать выше перечисленные тесты для определения показания к госпитализации для проведения расширенного обследования и лечения.

## Проявления кишечной недостаточности в хирургии позвоночника

**Умарходжаев Ф.Р., Нурмухамедов Х.К., Искандаров М.М., Алиев Т.Г., Маманазарова Д.К.**

*Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан*

**Цель исследования** – разработка ранней нутритивной поддержки у детей после операций на позвоночнике.

**Пациенты и методы.** Обследовано 56 (12–16 лет) детей с врожденными кифозами (18), кифосколиозами (14), сколиозами (24) которым в плановом порядке проводились истимические спондилолистезы, дегенеративные спондилолистезы (LII–LV) под общей тотальной внутривенной анестезией (ТВА – в положении на животе) в течении 4,2 ± 0,8 часов, с кровопотерей 80,1 ± 4,3 мл. Исследовали состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), моторно-эвакуаторную функцию (МЭФ), потребности пациентов в энергии (по уравнению Гарриса-Бенедикта), белках, жирах и углеводов. Энтеральное питание рекомендовали смесью «Нутрикамп-Файбер» (компания Б.Браун, Германия) обогащенная волокнами с общим количеством (в 100 г смеси) 6,5 г; растворимых 1,4 г; нерастворимых 5,1 г., в послеоперационном периоде через 20 ± 3,5 часа при парезе кишечника (ПК) 1-й степени у 58,2% детей; при ПК 2-й степени – у 36,4%; при ПК 3-й степени – у 5,4%.

**Результаты.** Согласно предварительным данным проведенных исследований «условное голодание» накануне операции и в послеоперационном периоде негативно сказывается на результатах оперативного лечения (парез ЖКТ, нарушение МЭФ), в связи с чем всем больным накануне операции назначали «Нуртикомп Файбер (500 мл). При этом учитывали метаболизм белков (альбумин). Анализ уровня мочевины отмечен достоверным снижением у всех пациентов, что указывал на переход от катаболизма к анаболизму. На фоне энтерального питания были устранены симптомы кишечной аритмии, нормализовалась фаза дефекации с восстановлением ее физиологической регулярности. Бактериологическое исследование на дисбактериоз отмечено положительно направленным изменением состава кишечной микрофлоры в виде увеличения бифидо-и лактобактерий, уменьшения условно-патогенной флоры (протея, грибов *Candida*, кишечной палочки с атиличными свойствами, что значительно снижало риск возможности микробной транслокации и сеп-

$p < 0,05$), низкие показатели диастолического кровотока Vmin (8,4 ± 0,57 см/сек и 8,9 ± 1,82 см/сек против 12,9 ± 1,46 см/сек, $p < 0,05$) в отличие от здоровых детей.

**Выводы.** Недоношенные дети – группа высокого риска по развитию различной патологии как в перинатальном периоде, так и за его пределами. Сочетанное воздействие повреждающих факторов на плод и новорожденного (недоношенность, рождение оперативным путем, негативное влияние гипоксии-ишемии) способствуют нарушению гемодинамической адаптации, в частности формированию адекватной ренальной гемодинамики.

## Встречаемость сочетанных заболеваний при хронической гастродуоденальной патологии у школьников

**Турдыева Ш.Т.**

*Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан*

В структуре патологии пищеварительного тракта у детей ведущее место занимают хроническая гастродуоденальная патология (ХГДП) (Шестопалова М.А., 2012). Следовательно, изучение сопутствующих болезней при ХГДП сохраняет свою актуальность в современной детской гастроэнтерологии.

**Цель.** Изучение встречаемости сочетанных заболеваний при хронической гастродуоденальной патологии у школьников.

**Пациенты и методы.** Были обследованы 286 детей и подростков от 6 до 15 лет с ХГДП. Среди обследованных хронический гастродуоденит (ХГД) был диагностирован у 174 (60,84%), хронический гастрит различных форм – 43 (15,03%), хронический дуоденит – 22 (7,69%), язвенная болезнь желудка – 8 (2,8%) и язвенная болезнь двенадцатиперстного кишечника (ЯБДПК) у 39 (13,64%) пациентов.

**Результаты.** В ходе нашего исследования, было отмечено, что у 214 (74,8%) детей школьного возраста с ХГДП, основное заболевания протекает в сочетании с другими патологиями желудочно-кишечного тракта. У 57,7% детей диагностирован хеликобактериоз. При этом, следует отличить сопутствующею патологию от сочетанной. Хотя оба термина по смыслу очень похоже, но по медицинской терминологии отличаются. Заболевания, ставшие причиной или сами возникшие после основной патологии, интерпретируются как сочетанная патология. В ходе исследования у 156 (72,9%) из 214 школьников с ХГДП эндоскопически была диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При этом ГЭРБ с эзофагитом отмечено у 62 (29%) пациентов, с эрозиями пищевода – 21 (9,8%). У 41 (19,2%) школьников с ХГДП эндоскопически диагностирована диодено-гастральный рефлюкс (ДГР).

Одновременно у 87 (30,4%) пациентов отмечена сочетание ХГДП с патологией билиарной системы: хронические холециститы – у 29 (13,55%), дискинезии желчных путей – 58 (27,1%) пациентов. Реактивном панкреатит диагностирован у 8 (3,7%) школьников с ХГДП.

Изменения поджелудочной железы и гепатобилиарной системы наиболее были выражены при ЯБДК и меньше при неязвенных поражениях желудка и 12-перстной кишки.

**Вывод.** Полученные данные показали, что у детей и подростков школьного возраста с ХГДП в 74,8% случаев отмечается сочетание данной патологии с ГЭРБ, ДГР, а также заболеваниями биларной системой и поджелудочной железой. При этом данные сочетания меняются в зависимости от клинической формы ХГДП.

## Определение уровня комплайенса у родителей детей, находящихся на стационарном лечении

**Туякбаев А.М., Исмамбетова Г.К., Мамырбаева М.А., Сыдыгалиева З.М., Шильманова А.Б., Кушаева А.М.**

*Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, Актобе, Республика Казахстан*

Комплайенс (согласие, соответствие) – добровольное следование пациента предписанному ему лечению. Комплайенс описывает отношения врача к больному, трактовке правильности приема лекарственных средств, точности выполнения рекомендаций и формирования здорового образа жизни. Актуальность проблемы состоит в том, что по данным ВОЗ и Министерства здравоохранения врачи стационарного звена не в полном объеме дают необходимую информацию относительно лечения и дальнейшей реабилитации пациента, особенно если этот пациент детского возраста. Неполное информирование пациента о состоянии его здоровья, недостаточная поддержка больного и его родственников может повлиять на исход и прогноз заболевания.

**Цель исследовани.** Определить уровень комплайенса среди родителей, чьи дети находятся на стационарном лечении в детской клинической больнице.

**Материалы и методы.** В качестве обьекта исследования былиопрошены родители, находящиеся по уходу за детьми, в соматическом, неврологическом, травматологическом, нейрохирургическом и хирургическом отделениях. Опросник состоял из 14 вопросов с 2 вариантами ответа(да , нет).Обязательно перед исследованием было получено согласие главного врача на проведение анкетирования родителей детей, находившихся на стационарном лечении. Кроме того родители заполняли Информированное согласие на анкетирование.

**Результаты.** Было проведено анкетирование 90 родителей, чьи дети получали стационарное лечение. Результаты опроса разделили на группы относительно ответов: да,нет.Например: на вопрос: «Проявляет ли врач к вам во время обхода элементы эмпатии» утвердительно ответили 69 человек, что составляет 76,6 % из всех опрошенных. На вопрос: «Дает ли вам врач всю необходимую информацию относительного заболевания вашего ребенка» утвердительно ответили 71 родитель, что составляет 78,8%. 75,5% опрошенных утвердительно ответили на во-

# Тезисы
## VII Конгресса педиатров стран СНГ
# «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания»

23–24 октября 2015 г.
Сочи, Краснодарский край, Россия
SEA GALAXY Hotel